

Œsophagites caustiques

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Connaître les différents caustiques, leurs mécanismes de toxicité et leurs potentielles gravités
- Savoir évaluer la gravité de l'ingestion de caustique
- Savoir organiser la prise en charge lors des 24 premières heures
- Connaître les modalités de la prise en charge ultérieure

I. Définition et généralités :

1. Définition :

- Œsophagite caustique : c'est l'inflammation de la muqueuse œsophagienne secondaire à l'ingestion d'un produit caustique.

On définit comme caustique toute substance susceptible du fait de son pH ou de son pouvoir oxydant d'induire des **lésions tissulaires**.

Leurs répartition est diverse : Certains produits ménagers, certains produits agricoles et industriels et même pharmaceutiques peuvent être caustiques.

2. La brûlure du tractus digestif suite à une ingestion d'un produit caustique représente une urgence médico-chirurgicale multidisciplinaire.

3. Fréquence : Les lésions caustiques du tractus digestif supérieur (TDS) sont en passe de devenir un sérieux problème de santé publique du fait de la commercialisation anarchique de produits domestiques de plus en plus corrosifs et de l'absence de mesures préventives (5900 enfants/an/ sont touchés en Algérie; 15000 personnes/an en France et 35000/an aux USA).

4. Classification des produits caustiques : Ils sont classés en 4 catégories :

- **Les bases fortes (pH>12)** : La soude, potasse, ammoniac, oxyde et hydroxyde de calcium, phosphates et silicates de sodium.
- **Les acides forts (pH<2)** : Les acides chlorhydrique, sulfurique, nitrique, borique, phosphorique, acétique, fluorhydrique ou oxalique.
- **Les oxydants** : Hypochlorite de soude (Eau de javel), eau oxygénée, permanganate de potassium, peroxydes, borates (perborate de Na).

- **Divers:** Aldéhydes : formaldéhyde, acétaldéhyde, glutaraldéhyde, phénols (solution concentrée), époxydes.

II. Physiopathologie

- - Bases fortes : Nécrose de liquéfaction de l'épithélium et de la sous-muqueuse par saponification des lipoprotéines. L'absence de formation d'escarre favorise la pénétration en profondeur avec un risque de perforation possible à j4/j5
- - Acides forts : Nécrose de coagulation avec la formation d'une escarre qui limite l'effet de pénétration en profondeur. Ils provoquent plutôt des lésions gastriques et duodénales avec un risque de perforation précoce
- - La destruction tissulaire durant les 24-48 premières heures est aggravée par la surinfection bactérienne.
- - Les remaniements fibreux cicatriciels responsables d'adhérences voire de sténoses surviennent dès la 3^e semaine.
- - La réépithélisation se poursuit jusqu'à la 6^e semaine

III. Epidémiologie

- - 80% des ingestions caustiques chez les enfants (age de prédilection 2-6 ans)
- - Cause accidentelle chez l'enfant (la moitié des cas ont moins de 5 ans)
- - Cause volontaire chez l'adulte et l'adolescent
- - Prédominance féminine : 53-57% des cas
- - 110/100'000 personnes/an dans le monde
 - OMS2004:variabilitéavec19/100'000auxUSAet243/100'000enAsie
- - Mortalité de 4.8/100'000 cas (OMS 2004, 1% dans la phase aigue)
- - Risque de carcinome épidermoïde augmentée de 1'000 x par rapport à la population

générale avec une incidence de 2.3 à 6.2% et survenant en moyenne 40 ans plus tard, le plus souvent dans le tiers moyen de l'œsophage

IV. Symptômes

- - Brûlure buccale, thoracique, épigastrique
- - Dysphagie
- - Hypersialorrhée
- - Vomissements
- - Dyspnée
- - Choc

V. Diagnostic

- Anamnèse
- Examen buccal
- La présence d'une hypersialorrhée, de brûlures de la muqueuse buccale et d'une hyperleucocytose est habituellement associée à des lésions œsogastriques supérieures au stade 2b
- pas de corrélation entre l'intensité des symptômes et la gravité des lésions
- 30% de lésions œsophagiennes isolées sans lésions ORL

Bilan initial pour définir l'attitude thérapeutique

Biologique :

- FSC, CRP, pH, Na, K, Cl, Ca, Mg, urée, créatinine, LDH, CK, ASAT, ALAT, lactate, OH.
- (recherche

acidose métabolique, leucocytose, coagulopathie de consommation, hémolyse)

Endoscopie digestive haute :

De préférence en AG avec intubation pour prévenir le risque lié à l'inhalation.

insufflation au débit minimal pour éviter les risques de perforations.

Peut être effectué au nasofibroscope pour diminuer le risque de perforation.

Elle doit être faite **entre 6h00 et 24 heures post ingestion** pour ne pas sous-estimer les lésions ni d'augmenter le risque de complication. Elle doit être répétée dans les 48 heures si l'endoscopie a été incomplète

Éviter ensuite toute endoscopie jusqu'à la 2-3^e semaine

Scanner thoraco-abdominal (staging): meilleure performance du scan injecté comparé à l'endoscopie pour le jugement de la nécrose .

Classifications endoscopique selon Zargar

0 Normal

I Œdème et érythème

IIa Hémorragies muqueuse, ulcérations superficielles, fausses membranes

IIb Ulcérations creusantes et confluentes

IIIa Nécrose focale non circonscrite

IIIb Nécrose diffuse circonférentielle

Classifications des lésions caustiques selon le scanner

Stade 1 : organes normales, correspond au Zargar grades 0-2a.

Stade 2 : œdème de la paroi avec altération inflammatoire des organes dans l'entourage avec prise de contraste augmentée, correspond au stade endoscopique 2b-3b, sans nécrose transmurale.

Stade 3 : nécrose transmurale, pas de prise de contraste, correspond au grade 3b.

VI. Traitements d'urgences

- - Eviter les efforts de vomissements, les émétiques et ne pas effectuer de lavage gastrique
- - Laver les yeux et la face à l'eau stérile, retirer les vêtements imprégnés
- - Discuter d'une bronchoscopie dès le stade IIa
- - En cas de nécrose diffuse (dès le stade IIIb) : indication opératoire (oesophagectomie)
- - Grades I+IIa : à jeun 24h, régime liquide après 24h00 puis normal
- - Grades IIB à III : à jeun 48h00

Sonde d'alimentation pendant 3-6 semaines (SNJ ou jéjunostomie)

- - IPP : pas d'effet prouvé
- - Corticoïdes : pas indiqués
- - Pas de mise en place de sonde naso-gastrique à l'aveugle
- - Antibiotiques : en cas de lésions de stade 3 ou d'affection pulmonaire

VII. Complications

- - HDH
- - Perforations digestives, fistules
- - Surinfections
- - Sténose oesophagienne tardive après 3 semaines (complication la plus fréquente, 24% des

cas) souvent longue, tortueuse et multiples : les dilatations précoces entre 3-6 semaines ont montré de meilleurs résultats de la dilatation qu'après 6 semaines, CAVE: risque de perforation entre 4-17%.

- - Stent oesophagien : efficacité limitée (dysphagie par stent, réaction tissulaire hyperplasique. Pneumopathie d'inhalation (11%) et défaillance respiratoire (8%))
- - Complication métabolique en fonction du produit ingéré (rénale, hépatique)
- - Risque de carcinome épidermoïde de l'œsophage

VIII. Surveillance

Stade IIA : - OGD + transit oesophagien à 1, 3, 6 et 12 mois

Dès stade IIB : - OGD + transit oesophagien à 1, 3, 6, 12 et 24 mois

Pour tous les stades : - Dépistage du Ca épidermoïde après 15-20 ans de l'exposition : OGD tout les 1-3 ans (recommandations SFED et ASGE). Avant 15 ans d'évolution, OGD selon symptômes.

- Des colorations (acide acétique, lugol) sont recommandées pour le dépistage à un stade précoce.